

Патологогістологічне дослідження № 10307

Заклад	КНП "Золочівська центральна районна лікарня", ендо	Клінічні дані
ПІБ пацієнта	Серба Ірина Й	Дата отримання матеріалу 07.05.2025
Вік	1974 р.н.	Біопсія <u>первинна</u> , вторинна (підкреслити)
Стать	Жін.	При вторинній біопсії вказати номер і дату первинної
Телефон замовника		Біопсія діагностична
Лікуючий лікар	Грицьків М. В.	Дата і вид операції 30.04.2025 колоноскопія
Клінічний діагноз	Явища лівобічного коліту	

Дані про патологогістологічне дослідження

Маркування матеріалу, кількість об'єктів	2шм слизової з меж с\3 сигмовидної к-ки
Нумерація гістологічних блоків	39295-39296
Кількість блоків	2
Метод забарвлення	Гематоксилін/еозин
Макро і -мікроскопічний опис	В матеріалі фрагменти слизової оболонки, які гістологічно відповідають морфології товстої кишки типової архітекτονіки, взяті до підслизової основи; в стромі дифузна легка (на верхній межі норми) інфільтрація лімфоцитами, плазмоцитами, поодинокими еозинофілами з формуванням лімфоїдних фолікулів.
Патологогістологічний висновок (діагноз)	Гістологічна картина, при відповідних клінічних даних, може відповідати катаральному коліту.
Категорія складності	IV Категорія складності
Архівування вологого матеріалу	ні

Лікар-патологоанатом:

Міщенко К. С.
+380681475411

Лаборант:



Кошелюк Л. О.

Завідувач
гістологічної
лабораторії:Міщенко К.С.
+380681475411

Дата виконання: 09.05.2025

ФСУ - 7.4.010

Редакція 1 від 06.01.2025

Сторінки 1 з 1